EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La hipertensión (HT) es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular a nivel mundial. En la región de las Américas, 30 % de la población tiene presión arterial alta, siendo responsable del 30 % de las muertes (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2023). Es considerado un problema de Salud Pública, ya que las personas con menos recursos tienen más riesgo de enfermedades cardiacas, eventos cerebrovasculares, así como menos acceso a la prevención o al tratamiento (OPS, 2023). Según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de Costa Rica, durante el año 2022 se registró un aumento en las defunciones asociadas a la HT (Ministerio de Salud de Costa Rica [MINSA], 2023). Para el año 2021 en Costa Rica, se notificaron 19 507 nuevos casos con hipertensión, en promedio, 53 personas diagnosticadas diariamente con esta enfermedad (MINSA, 2023). Según la Encuesta de Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular, 2018; en la población general, la prevalencia de HT diagnosticada fue de 32,4 %, mientras que para la no diagnosticada fue de 4,8 % (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2021). El abordaje de esta patología y otras enfermedades crónicas está contenido en las Líneas Estratégicas Institucionales, en los puntos 2.a, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g y 2.h (CCSS, 2023).
Evidencia	En el 2021 el US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomendó el tamizaje de TA usando la toma de la presión arterial en el consultorio, para adultos de 18 años y más, y el monitoreo de esta fuera de los consultorios para el diagnóstico y confirmación antes de iniciar el tratamiento (Grado A). Los beneficios del tamizaje de la hipertensión son altamente certeros; además, cuando se fija un objetivo de Presión arterial (PA) más bajo (140 mmHg de PAS en la población general y 130 mmHg de PAS en una población de alto riesgo), estos compensan los daños de forma evidente. La certidumbre general varió de moderada a alta, dependiendo del valor de PA y el fármaco utilizado (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). La OMS recomienda (OMS, 2022): • Inicio del tratamiento farmacológico antihipertensivo en personas con diagnóstico confirmado de HT y PAS ≥140 mmHg o PAD ≥90 mmHg (Moderada a Alta). • Tratamiento farmacológico antihipertensivo: para las personas con enfermedades cardiovasculares existentes y PAS de 130-139 mmHg (Moderada a Alta); en personas sin enfermedades cardiovasculares, pero con riesgo cardiovascular alto, diabetes mellitus o insuficiencia renal crónica y PAS de 130-139 mmHg (Moderada a Alta). El objetivo de tratamiento establece una PA para los pacientes con HT sin comorbilidades es de <140/90 mmHg; y de PAS <130 mmHg en los pacientes con HT y enfermedades cardiovasculares (ECV) conocidas y en los de alto riesgo (aquellos con alto riesgo de ECV, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica) (Moderada).
Consideraciones de Implementación	<u>Limitaciones:</u> Áreas de Salud con Puestos de Visita Periódica (registros solo en Sistema Integrado de Agendas y Citas (SIAC)).

	Capacidad insuficiente de los servicios de salud para solventar la demanda (agendas saturadas y cupos reducidos). Horarios institucionales convencionales y semejantes a los laborales de la población. Proceso de toma de presión arterial inadecuado, donde no se cumple con el protocolo, existiendo deficiencias en la toma o el registro de cifras. Eventualidades en los sistemas informáticos de registro y almacenamiento (perdida de información e incapacidad de acceso). <u>Estrategias:</u> Mejorar la conectividad en los puestos de visita periódica, y uso de EDUS/SIES. Instaurar horarios de atención vespertinos y estimular los medios alternativos de atención. Mejorar los registros de atenciones y de las cifras de presión arterial tanto en el Sistema Integrado de Ficha Familiar (SIFF), como en Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES). Crear aplicativos que permitan acceso a la información necesaria para brindar una atención en salud al paciente en momentos de "caída" de los sistemas o de riesgos de seguridad informática, de manera que se permita el registro y consulta fuera de línea de las atenciones y luego estos datos se puedan migrar al EDUS.
Normativa Técnica	• Protocolo de atención clínica para la persona adulta y adulta mayor con presión arterial elevada e hipertensión arterial en el primer nivel de atención de la CCSS, 2025 • Norma Nacional para la atención de la hipertensión arterial en los servicios de salud, Nº 44466-S • Guía para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, 2015. • Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad 2022-2030. • Plan de sensibilización e información en salud cardiovascular, enfermedades no transmisibles y obesidad, 2023.
Costo / Efectividad	Un estudio costo-efectividad arrojó una disminución de los costos si los pacientes con hipertensión están controlados y esta reducción es aún mayor si reciben atención farmacéutica (Castro et al., 2016). El tratamiento de la HT (tratar a todos con PA ≥140/90 mmHg) ha demostrado ser rentable y una intervención idónea, según el estudio de Kostova. Tratar a los pacientes de alto riesgo o con ECV y PA basal de 130-139 mmHg ha demostrado ser rentable, pero no ahorra costos (análisis de rentabilidad del estudio SPRINT); el valor depende de mantener el efecto de la intervención durante más de cinco años (OMS, 2022). En lo que respecta a los costos, Jacob et al. resumieron los datos de 31 estudios (24 de los EE.UU.) e indicaron que los estudios que emplean estrategias de trabajo en equipo comunitario producen un ahorro de costos en general. La mayoría de las estimaciones de años de vida ajustados por costo/calidad (AVAC) oscilaron entre US$ 3 888 y US$ 24 000/AVAC, y en ellas, los programas dirigidos por farmacéuticos fueron más rentables que los dirigidos por profesionales de enfermería (OMS, 2022).
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar el porcentaje de acceso de las personas con HT a los servicios de atención en salud y así, se controlen sus cifras de presión arterial. Establecer el porcentaje de personas con control óptimo de presión arterial, de acuerdo con sus factores de riesgo, grupo de edad y sexo, de manera que se contribuya a disminuir su riesgo cardiovascular, carga de enfermedad y morbimortalidad, desde una visión integral y articulada.

Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la variación interanual en la cobertura de atención personas con HT? ¿Cuál es el porcentaje de personas atendidas en primer nivel de atención cuyas cifras de presión arterial son óptimas según sus factores de riesgo?
Indicadores asociados a la intervención	07-01-2.0 Cobertura de atención a personas con HT. 07-02-2.0 Control óptimo de la presión arterial en personas con HT.
Anexos	Oficio GM-DDSS-2487-2025. Respuesta a oficios GM-DCSS-0256-2025 Y GM-DCSS-0264-2025. Martes 07 de octubre de 2025. Criterio técnico sobre cifras de control óptimo. Dr. Jorge Ignacio Borbón Guevara. Coordinador del Programa de Normalización de la Atención a la Persona Adulta y Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Área de Atención Integral a las Personas Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud Martes, 18 de noviembre de 2025.
Referencias Bibliográficas	Anstey, E., Bradley, C., Shimbo, D. (2021). USPSTF Recommendation Statement on Hypertension Screening in Adults—Where Do We Go From Here? JAMA Netw Open, 4(4). doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.4203 Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2018). Plan Estratégico Institucional 2019-2022. CENDEISSS. https://www.cendeisss.sa.cr/wp/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL-2019-2022.pdf Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular, tercera encuesta 2018. San Jose: EDNASS-CCSS. Castro, L. P., Soria, I. C., Casco, E. C., & Vallejo, M. D. (2016). Análisis de costo-efectividad e impacto presupuestal de un programa de atención farmacéutica para pacientes hipertensos de un hospital de tercer nivel de México. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 25. Ministerio de Salud de Costa Rica. (17 de mayo de 2023). Medí tu presión arterial con precisión, contrólala, viví más. Ministerio de Salud Gobierno de Costa Rica. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/60-noticias-2023/1592-casosnotificados-de-hipertension-arterial-disminuyen-un-19-6-durante2022#:~:text=Sin%20embargo%2C%20las%20defunciones%20asociadas,muertes%20asociadas%20a%20esta%20enfermedad. Organización Mundial de la Salud. (2022). Directriz para el tratamiento farmacológico de la hipertensión en adultos. Organización Mundial de la Salud. https://iris.who.int/handle/10665/364491 Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (21 de agosto de 2023). Hipertensión. OPS. https://www.paho.org/es/temas/hipertension2Laquesis#Atropo